

Neuropsicología Universitaria

BLOQUE III

Estudio de Casos Clínicos: del síntoma al diagnóstico

Módulo VI · 10 casos clínicos · Integración de los tres bloques

Luis Ángel González Ortega · I Aprendizaje

Este bloque integra los contenidos de los Bloques I y II mediante el análisis detallado de diez casos clínicos que cubren los principales síndromes neuropsicológicos. Cada caso incluye presentación clínica, perfil de evaluación con puntuaciones reales, diagnóstico razonado, plan de rehabilitación y reflexión integradora. Dos de los diez casos abordan específicamente perfiles infantiles con altas capacidades y doble excepcionalidad.

Casos incluidos en el Bloque III

Caso 1	Afasia de Broca tras ictus isquémico en ACM izquierda	Varón · 62 años
Caso 2	Síndrome Amnésico puro tras encefalitis herpética bilateral	Mujer · 47 años
Caso 3	Negligencia Espacial Unilateral izquierda tras ictus parietal derecho	Varón · 71 años
Caso 4	Doble Excepcionalidad: AACC con TDAH comórbido (2e)	Varón · 9 años · 4.º Primaria
Caso 5	Demencia Frontotemporal variante conductual (DFTvc)	Varón · 58 años
Caso 6	TCE moderado: síndrome post-conmocional crónico	Mujer · 34 años
Caso 7	Enfermedad de Alzheimer en fase leve — diagnóstico diferencial con DCL	Mujer · 73 años
Caso 8	Dislexia enmascarada por AACC: la lectora que compensa pero no disfruta (2e)	Niña · 10 años · 5.º Primaria
Caso 9	Prosopagnosia adquirida tras encefalitis vírica	Mujer · 41 años
Caso 10	Síndrome Disejecutivo grave: CI conservado, vida destruida	Varón · 29 años

Análisis de Casos Clínicos

Bloque I · Módulo II · Lenguaje

Caso 01 · Afasia de Broca tras ictus isquémico en ACM izquierda

Varón · 62 años · Diestro · Ingeniero jubilado

Presentación clínica

Paciente derivado 3 semanas después de un ictus isquémico en el territorio de la ACM izquierda. RMN: infarto en el giro frontal inferior izquierdo (áreas 44-45) con extensión a la ínsula anterior. La familia refiere: "habla con mucho esfuerzo, en telegráfico, pero entiende todo lo que le decimos".

Perfil de evaluación neuropsicológica

Test / Función	Resultado	Interpretación
Fluencia del habla espontánea	No fluente — <50 palabras/min, agramatismo	Muy alterada
Comprensión oral (Token Test)	28/36 — percentil 60	Conservada
Repetición (BDAE)	Palabras 6/10 — Frases 2/10	Significativamente alterada
Denominación por confrontación	12/20 — dificultades en verbos de acción	Moderadamente alterada
Escritura espontánea	Agramática, omisiones de morfemas	Muy alterada
Comprensión lectora	Conservada para frases simples	Conservada

Diagnóstico

Afasia de Broca (no fluente, comprensión conservada, repetición alterada) secundaria a infarto en el giro frontal inferior izquierdo. El agramatismo —omisión de morfemas gramaticales y producción telegráfica— es el signo clínico característico.

Plan de rehabilitación

- Logopedia intensiva diaria (45 min/sesión, 5 días/semana) en fase subaguda — máxima plasticidad.
- Técnica PACE para restaurar la funcionalidad comunicativa en contextos naturales.
- Tratamiento de Acceso Léxico: facilitación fonológica y semántica para denominación de verbos.
- CAA como soporte: tablero de comunicación para situaciones urgentes.
- Psicoeducación familiar: estrategias de comunicación facilitadora.

Reflexión integradora

Este caso ilustra la disociación producción/comprensión predicha por el modelo de Boston y la correlación clínico-anatómica entre el área de Broca y el habla no fluente agramática. La fase subaguda es el período de mayor eficacia rehabilitadora, coincidiendo con el pico de plasticidad (resolución de diasquisis + reorganización cortical).

Bloque I · Módulo II · Memoria

Caso 02 · Síndrome Amnésico puro tras encefalitis herpética bilateral

Mujer · 47 años · Diestra · Profesora de secundaria

Presentación clínica

PCR confirma encefalitis por VHS-1. RMN: afectación necrótica bilateral de ambos lóbulos temporales mediales. La paciente refiere: "sé perfectamente quién soy y lo que sé de mi trabajo, pero no recuerdo nada de lo que me pasa cada día".

Perfil de evaluación

Test / Función	Resultado	Interpretación
RAVLT — Aprendizaje (ensayo 5)	4/15 palabras	Grave déficit de codificación
RAVLT — Recuerdo libre demorado	0/15 palabras	Amnesia anterógrada severa
RAVLT — Reconocimiento	9/15	Leve facilitación por reconocimiento
Figura de Rey — Copia	32/36 puntos	Conservada
Figura de Rey — Recuerdo demorado	3/36 puntos	Amnesia visoespacial severa
Memoria semántica (conocimiento profesional)	Conservada	Sistema semántico preservado
Memoria procedimental (habilidades motoras)	Adquisición normal de habilidades nuevas	Sistema procedimental preservado
CI estimado (WAIS-IV)	112 — percentil 79	Inteligencia conservada

Diagnóstico

Síndrome amnésico grave de origen encefalítico. Amnesia anterógrada severa multimodal con afectación de la consolidación hipocampal bilateral. Memoria semántica y procedimental preservadas. La disociación replica el perfil del caso H.M. (Molaison, 1953), confirmando el papel selectivo del hipocampo en la memoria declarativa.

Plan de rehabilitación

- Sistema de memoria externa estructurado: agenda electrónica con alarmas, cámara de fotos, pizarra con información temporal actualizada.
- Errorless Learning para información nueva imprescindible (nombres del equipo sanitario, teléfonos, rutinas).
- Spaced Retrieval para consolidar información personal relevante (citas médicas, nuevos conocidos).

- Psicoterapia de adaptación al déficit: duelo por las pérdidas funcionales y de identidad profesional.
-

Caso 03 · Negligencia Espacial Unilateral izquierda tras ictus parietal derecho

Varón · 71 años · Diestro · Comerciante retirado

Presentación clínica

Ictus hemorrágico en el lóbulo parietal inferior derecho. La familia refiere: "solo come la mitad del plato, lee solo la mitad del periódico, se afeita solo el lado derecho de la cara". Agudeza visual bilateral normal.

Perfil de evaluación

Test / Función	Resultado	Interpretación
Test de cancelación (Albert)	Omisión del 80% de dianas en hemicampo izq.	Negligencia severa
Bisección de líneas	Desviación sistemática a la derecha (+3,2 cm)	Negligencia peripersonal
Copia de figura de Rey	Solo dibuja la mitad derecha	Negligencia en copia
Campo visual (Confrontación)	Normal bilateralmente	Sin hemianopsia
Anosognosia (Bisiach)	Grado 2 — niega parcialmente el déficit	Anosognosia moderada

Diagnóstico

Negligencia espacial unilateral izquierda grave con anosognosia moderada, secundaria a ictus hemorrágico en el lóbulo parietal inferior derecho. Afectación de la red atencional dorsal del hemisferio derecho. El campo visual normal confirma que no es hemianopsia.

Plan de rehabilitación

- Scanning training: entrenamiento en exploración del hemicampo izquierdo con ancla visual roja.
- Estimulación calórica vestibular: irrigación de agua fría en el oído izquierdo.
- Prismas ópticos: adaptación que reduce el neglect a largo plazo.
- Trabajo sobre anosognosia mediante vídeo-feedback (prerequisito para la intervención).

Caso 04 · Doble Excepcionalidad: AACC con TDAH comórbido (2e)

Varón · 9 años · 4.º Educación Primaria · Derivado por el equipo docente

Motivo de consulta

El equipo docente deriva al alumno por "rendimiento muy irregular, comportamiento disruptivo, no termina las tareas, parece aburrido pero cuando le interesa algo es brillante". La madre refiere que "habla de dinosaurios o del universo durante horas con una profundidad impresionante". Sin evaluación

psicopedagógica previa.

Perfil de evaluación

Test / Función	Resultado	Interpretación
WISC-V — CI Total	136 (percentil 99)	Altas Capacidades Intelectuales
WISC-V — Comprensión Verbal	148 (percentil 99,9)	Excepcional
WISC-V — Razonamiento Fluido	139 (percentil 99,5)	Muy superior
WISC-V — Memoria de Trabajo	104 (percentil 61)	Media — discrepancia significativa
WISC-V — Velocidad de Procesamiento	98 (percentil 45)	Media — discrepancia muy significativa
BRIEF-2 (padres) — Inhibición	T=78 — clínicamente significativo	Déficit grave de inhibición
BRIEF-2 (profesores) — MdT	T=74 — clínicamente significativo	Déficit funcional escolar
CPT-3 — Omisiones	T=72 — por encima del corte	Déficit de atención sostenida
Conners-3 (padres) — Total TDAH	T=76 — muy significativo	Perfil compatible con TDAH
NEPSY-II — Narrativa	Percentil 98	Capacidad narrativa excepcional

Diagnóstico

Doble Excepcionalidad (2e): Altas Capacidades Intelectuales (CI 136) + TDAH presentación combinada (DSM-5). Las AACC han enmascarado el TDAH durante años: el alto CI compensaba los déficits ejecutivos hasta que la demanda escolar ha superado la capacidad de compensación. El perfil WISC-V + BRIEF-2 + CPT-3 es diagnóstico del perfil 2e.

Plan de intervención

- Valoración neuropsiquiátrica para tratamiento farmacológico (metilfenidato) como parte del tratamiento multimodal.
- En el aula: enriquecimiento curricular + tareas en pasos cortos con lista de verificación + ubicación preferente + tiempo adicional.
- Entrenamiento ejecutivo: autoinstrucciones y GMT adaptado para 9 años.
- Psicoeducación al alumno: su cerebro va muy rápido en algunas cosas y necesita ayuda para organizarse en otras.
- Protocolo AACC + medidas TDAH según Decreto 38/2022 CyL.

Reflexión para el Maestro de Primaria

El "efecto paraguas" de las AACC puede durar años, pero eventualmente la demanda escolar supera la compensación y el alumno colapsa. La clave es no interpretar el fracaso como desmotivación: el alumno AACC con TDAH trabaja más que sus pares para obtener los mismos resultados, y ese sobreesfuerzo genera agotamiento cognitivo y frustración acumulada.

Caso 05 · Demencia Frontotemporal variante conductual (DFTvc)

Varón · 58 años · Diestro · Director de empresa

La esposa refiere cambio radical de personalidad en 18 meses: pérdida del empleo por comentarios inapropiados, ingesta compulsiva (+12 kg), conducta sexual inapropiada. El paciente no reconoce ningún problema. RMN: atrofia frontal y temporal anterior bilateral.

Perfil de evaluación

Test / Función	Resultado	Interpretación
MMSE	27/30	Sin deterioro cognitivo global aparente
Fluidez verbal fonológica (FAS)	18 palabras — percentil 5	Grave déficit
WCST — Perseveraciones	48% respuestas perseverativas	Grave déficit de flexibilidad
Iowa Gambling Task	Estrategia de riesgo extremo; no aprende del castigo	Grave déficit de toma de decisiones
Test de la Mente en los Ojos	9/36 — muy por debajo de la norma	Grave déficit de Teoría de la Mente
WMS-IV — Memoria episódica verbal	Percentil 42	Conservada
NPI (familiar) — Desinhibición	12/12 — máxima severidad	Síntoma cardinal

Diagnóstico

Demencia Frontotemporal variante conductual (DFTvc) según criterios de Rascovsky et al. (2011). La memoria episódica relativamente conservada con grave deterioro ejecutivo y de la cognición social es el criterio diferencial clave con la EA.

Caso 06 · TCE moderado: síndrome post-conmocional crónico

Mujer · 34 años · Diestra · Enfermera · Accidente de tráfico

TCE moderado cerrado (GCS 11; pérdida de consciencia 45 min) hace 8 meses. RMN con DTI a los 3 meses: alteraciones en sustancia blanca frontal bilateral (daño axonal difuso). No puede reincorporarse al trabajo: "no me puedo concentrar, me equivoco en las dosis".

Perfil de evaluación

Test / Función	Resultado	Interpretación
Velocidad de procesamiento (WAIS-IV)	Índice 78 — percentil 7	Significativamente reducida
TMT-B	310 seg — percentil 3	Grave déficit ejecutivo

Test / Función	Resultado	Interpretación
CPT-3 — Variabilidad RT	T=73 — elevado	Inconsistencia atencional marcada
RAVLT — Recuerdo demorado	7/15 — percentil 28	Dentro de la norma ajustado por velocidad
Stroop — Interferencia	Percentil 6	Grave déficit de inhibición
Fatiga cognitiva (MFI-20)	72/100	Fatiga grave en los 5 dominios
BDI-II	18 — depresión leve-moderada	Comorbilidad depresiva
CI premórbido (NART)	115 — percentil 84	Rendimiento premórbido superior

Diagnóstico

Síndrome post-conmocional crónico (ICD-11: 6D80) con perfil de daño axonal difuso: deterioro selectivo de velocidad de procesamiento, atención e inhibición con relativa preservación de la memoria declarativa. La discrepancia con el CI premórbido estimado (115) confirma el deterioro adquirido.

Plan de rehabilitación

- APT-3: programa jerárquico de rehabilitación atencional en sesiones cortas (20 min) con descansos programados.
- Gestión de la fatiga cognitiva: técnicas de pacing.
- Tratamiento de la depresión comórbida: TCC o ISRS según evaluación psiquiátrica.
- Reincorporación laboral gradual y supervisada: inicio con 2 h/día en tareas de baja demanda.

Caso 07 · Enfermedad de Alzheimer en fase leve — diagnóstico diferencial con DCL

Mujer · 73 años · Diestra · Maestra de primaria jubilada · 35 años de docencia

La hija consulta por olvidos frecuentes de conversaciones y desorientación. RMN: atrofia hipocampal bilateral.

Perfil de evaluación

Test / Función	Resultado	Interpretación
MMSE	22/30	Por debajo del punto de corte
MoCA	17/30	Deterioro significativo
RAVLT — Aprendizaje (ensayo 5)	5/15	Curva de aprendizaje muy plana
RAVLT — Recuerdo libre demorado	1/15	Amnesia anterógrada severa
Denominación (BNT-15)	9/15 — errores semánticos	Anomia moderada
Orientación (MMSE)	4/10	Desorientación temporo-espacial
Lawton y Brody (AIVD)	4/8 — dependiente en cocina, finanzas, transporte	Impacto funcional significativo

Diagnóstico y diagnóstico diferencial

Enfermedad de Alzheimer en fase leve (NIA-AA, 2011). El diagnóstico diferencial con DCL se resuelve por el impacto funcional significativo en AIVD (4/8): el DCL, por definición, no produce impacto funcional. Su reserva cognitiva (35 años de docencia) puede haber retrasado la aparición de síntomas.

Conexión con la práctica docente

Su reserva cognitiva, construida durante 35 años de docencia activa, probablemente ha retrasado años la aparición de síntomas. Lo que construyes en el aula —en tus alumnos y en ti mismo— es una inversión directa en la salud cerebral a largo plazo.

Caso 08 · Dislexia enmascarada por AACC: la lectora que compensa pero no disfruta

Niña · 10 años · 5.º Educación Primaria

Derivada por "leer muy lento y cometer muchos errores aunque comprende perfectamente". Destaca por su vocabulario rico y capacidad de razonamiento. Evita leer en voz alta. Nunca ha recibido evaluación psicopedagógica.

Perfil de evaluación

Test / Función	Resultado	Interpretación
WISC-V — CI Total	128 (percentil 97)	Altas Capacidades
WISC-V — Comprensión Verbal	141 (percentil 99,7)	Excepcional
WISC-V — Velocidad de Procesamiento	95 (percentil 37)	Media — discrepancia intraindividual
PROLEC-R — Precisión lectora	Percentil 10	Déficit significativo de decodificación
PROLEC-R — Velocidad lectora	Percentil 5	Déficit grave de fluidez
PROLEC-R — Comprensión lectora	Percentil 85	Conservada — compensa con el CI
Conciencia fonológica (PECO)	Percentil 8	Déficit fonológico nuclear
Denominación rápida letras (RAN)	Percentil 7	Déficit de automatización
Escritura al dictado (PROESC)	Percentil 12	Errores ortográficos frecuentes

Diagnóstico

Doble Excepcionalidad (2e): AACC (CI 128) + Dislexia del Desarrollo (DSM-5). La comprensión está conservada porque el alto CI permite inferir significado mediante contexto y vocabulario, compensando el déficit fonológico. El "techo" de compensación se ha alcanzado en 5.º de primaria.

Reflexión para el Maestro

Ha llegado a 5.º sin diagnóstico porque "saca buenas notas". Años sintiéndose "tonta" pese a sus capacidades generan una herida de identidad que va mucho más allá del déficit lector. La detección temprana en 1.º-2.º de primaria habría evitado ese sufrimiento innecesario.

Caso 09 · Prosopagnosia adquirida tras encefalitis vírica occípito-temporal bilateral

Mujer · 41 años · Diestra · Médica de familia

"Ya no reconozco a nadie por la cara, ni a mi marido ni a mis hijos. Los reconozco por la voz, la ropa o cómo andan." Encefalitis vírica (probable CMV) con afectación occípito-temporal bilateral. Agudeza visual normal.

Perfil de evaluación

Test / Función	Resultado	Interpretación
Reconocimiento de caras famosas (CFMT)	18% de aciertos (norma: 80%)	Prosopagnosia grave
Test caras de Benton	Percentil 3	Déficit perceptivo de rostros
Reconocimiento de expresiones (Ekman)	62% (norma: 88%)	Moderadamente reducido
Reconocimiento de objetos (BORB)	Normal — percentil 68	Agnosia específica para rostros
Reconocimiento de voces	Normal — reconoce a todos por la voz	Modalidad auditiva preservada
Acuidad visual (Snellen)	20/20 bilateral	Visión normal

Diagnóstico

Prosopagnosia adquirida (agnosia asociativa para rostros) secundaria a encefalitis con probable daño del Área Fusiforme de Rostros (FFA, Kanwisher et al., 1997). La especificidad para rostros —con objetos y voces preservados— confirma el diagnóstico.

Reflexión integradora

Ilustra la doble disociación entre reconocimiento de rostros y de objetos: evidencia de módulos funcionales especializados. La preservación del reconocimiento por voz confirma que el problema es de procesamiento visual específico para configuraciones faciales, no de memoria.

Caso 10 · Síndrome Disejecutivo grave: CI conservado, funcionamiento destruido

Varón · 29 años · Diestro · Arquitecto en activo

Meningitis bacteriana grave (*S. pneumoniae*) con infarto frontal bilateral hace 7 meses. Sin déficits motores ni sensoriales. La esposa refiere: "empieza las cosas y no las termina, hace lo que se le ocurre sin pensar en consecuencias". Él lo minimiza.

Perfil de evaluación

Test / Función	Resultado	Interpretación
CI premórbido (WTAR)	118 estimado — percentil 88	Alto rendimiento premórbido
CI actual (WAIS-IV)	107 — percentil 68	Dentro de la norma; declive de 11 puntos
WCST — Categorías completadas	2/6	Grave déficit de formación de conceptos
WCST — Errores perseverativos	41%	Rigidez cognitiva marcada
Torre de Londres	4/10 correctos	Grave déficit de planificación
TMT-B/A ratio	4,8 (norma: <3)	Grave déficit de flexibilidad
Iowa Gambling Task	Estrategia de riesgo; no aprende del castigo	Déficit de toma de decisiones
RAVLT — Memoria episódica	Percentil 52	Conservada
BRIEF-A (esposa)	T=80 — muy significativo	Discrepancia auto/hetero: anosognosia parcial

Diagnóstico

Síndrome Disejecutivo grave secundario a lesión frontal bilateral post-meningítica. El CI conservado explica la "paradoja del paciente frontal": las pruebas de CI miden habilidades cristalizadas que no requieren la regulación ejecutiva de la vida cotidiana.

Plan de rehabilitación

- Goal Management Training (GMT): detener la conducta automática, definir metas, monitorizar.
- Problem Solving Therapy: algoritmo de 5 pasos aplicado a situaciones de arquitectura.
- Trabajo sobre anosognosia mediante vídeo-feedback.
- Reincorporación laboral gradual y supervisada con feedback frecuente.

Reflexión final — Cierre del Curso

Las funciones ejecutivas son el "director de orquesta" del cerebro: sin ellas, los instrumentos pueden estar afinados pero la música es caótica. Su rehabilitación es el reto más complejo de la práctica neuropsicológica. El cerebro humano, en toda su complejidad, no termina de revelar sus secretos.